

1. Пальцьове дослідження прямої кишки ; (ЖКХ)

Сценарій.

Ви черговий хірург лікарні. Бригадою швидкої медичної допомоги до приймального відділення доставлений пацієнт 73 років з діагнозом: “Механічна жовтяниця”.

Скарги: на інтенсивну біль у правому підребер’ї, жовтушність шкірних покривів, освітлення калу, сечу коліру пива, підвищення температури тіла до 38°C, шкіряний зуд.

Анамнез захворювання: На протязі 10 років страждає на ЖКХ. Раз на рік були приступи болі у правому підребері. У цьому випадку вважає себе хворим протягом доби, коли з’явилися болі в лівому підребер’ї, нудота, блювання, що пов’язує з вживанням алкоголю напередодні. Не дивлячись на самолікування прийом “Но-шпи”, “Омес” з’явилися нудота, багаторазове блювання. Пожовтів 3 доби потому. З плином часу біль посилилась, жовтяниця narosla, підвищилась температура тіла, що стало причиною виклику БШМД.

Анамнез життя: Цукровий діабет, туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ-інфекцію заперечує. Хворів ГРВІ. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій немає.

Спадковість: необтяжена.

Об’єктивно: стан середньої тяжкості, у свідомості, положення активне. Шкіра жовта, суха, на передній поверхні черевної стінки розчеси внаслідок шкіряного зуду. Ріст 175 см, вага 90 кг. Периферичний набряків немає. В акті дихання відстає ліва половина грудної клітини, шкірні покриви не змінені. При пальпації локальної болючості, підшкірної емфіземи немає. При порівняльній перкусії: ясний легeneвий звук з обох боків притуплення перкуторного звуку немає. При аускультатії легень з обох боків везикулярне дихання; ЧДР 22 за хв. Межі відносної серцевої тупості не розширені. Тони серця ясні ритмічні, патологічних шумів немає. ЧСС=Пс=102 за хв., АТ ліва рука 140/90 мм рт.ст., АТ права рука 140/ 90 мм рт.ст. Живіт симетричний, вздутый, приймає участь у акті дихання. При пальпації м’який, болючий у правому підребер’ї. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Симптом Ортнера, Кохера, Мюссі позитивні. Аускультативно - ослаблена перистальтика. Ділянка попереку без патології. Нирки не пальпуються. Випорожнень не було протягом доби. Сечовипускання безболісне, вільне. Діурез зменшений.

Додатково:

Клінічний аналіз

Показник	Значення	Норма
Гемоглобін (г/л)	138	120-140
еритроцити (10 ¹² /л)	4,43	3,9-4,7
Кольоровий показник	0,9	0,85-1,15
Тромбоцити (10 ⁹ /л)	252	180-320

Лейкоцити (10 ⁹ /л)	10,3	4,0-9,0
Лімфоцити %	19	19-37%
Еозинофіли %	5	0,5-5
Паличкоядерні нейтрофіли %	10	1-6%
Сегментоядерні нейтрофіли %	74	47-72%
Моноцити %	11	3-11%
ШЗЕ	35	5-15

Біохімічний аналіз крові

Показник	Значення	Норма
Загальний білок	64	65-85г/л
Аланін амінотрансфераза (АлАТ)	107,1	Чол. до 41 Од/л Жін. до 31 Од/л
Аспарат-амінотрансфераза (АСТ)	93,3	Чол. до 37 Од/л Жін. до 31 Од/л
Амілаза крові	86	До 90 Од/л
Загальний білірубін	105,5	5-21 мкмоль/л
прямий	93,2	До 6,8 мкмоль/л
непрямий	22,3	5-14,2 мкмоль/л
Сечовина	8,4	2,49-8,3 ммоль/л
Креатинін	59,8	Чол. до 62-115 мкмоль/л Жін. 53-97 мкмоль/л
Глюкоза	13,2	4,1-5,9 ммоль/л

Ультразвукове дослідження черевної порожнини



№п/п	Дії	Текст
1.Комунікативні навички		
1.1	Привітатися.	Доброго дня.
1.2	Ви даєте свою згоду на проведення клінічного обстеження?	Так
Збір скарг та анамнезу		
2.1	Які у Вас скарги?	на інтенсивну біль у правому підребер'ї, жовтушність шкірних покривів, освітлення калу, сечу кольору пива, підвищення температури тіла до 38С, шкіряний зуд.
2.2	Коли з'явилися скарги, що з Вами трапилось?	На протязі 10 років страждає на ЖКХ. Раз на рік були приступи болі у правому підребері. У цьому випадку вважає себе хворим протягом доби, коли з'явилися болі в лівому підребер'ї, нудота, блювання, що пов'язує з вживанням алкоголю напередодні. Не дивлячись на самолікування прийом "Но-шпи", "Омез" з'явилися нудота, багаторазове блювання. Пожовтів 3 доби потому. З плином часу біль

		посилилась, жовтяниця narocлa, підвищилась температура тіла, що стало причиною виклику БШМД.
2.3	Якими захворюваннями перехворіли? Чи є алергія? Чи були операції?	Цукровий діабет, туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ інфекцію заперечує. Хворів ГРВІ. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій немає. Спадковість: необтяжена.
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Огляд з верифікацією виявлених патологічних змін.	Я проводжу огляд з верифікацією виявлених патологічних змін Я оглядаю пацієнта — шкіра та склери жовтяничні, спостерігаю розчухи на животі. Живіт помірно здутий, бере участь у диханні. Звертаю увагу на наявність гіперпигментованої сечі (пацієнт описує як "пивного кольору") та знебарвлення калу.
3.2	Пальпація з верифікацією виявлених патологічних змін	Я виконую пальпацію з верифікацією виявлених патологічних змін Пальпація живота виявляє болючість у правому підребер'ї. Позитивні симптоми Ортнера(бью ребра), Кера (прямая мышцы живота X реберна дуга), Мерфі(надуть живот), Мюссі (болит между ножками грудинно-ключ-сосц справа) — свідчать про запалення жовчовивідних шляхів. Печінка не пальпується нижче реберної дуги, жовчний міхур не виявляється (може бути зумовлено набряком).
3.3	Перкусія з верифікацією виявлених патологічних змін	Я виконую перкусію з верифікацією виявлених патологічних змін Перкуторно — межі печінки в нормі, притуплення в проекції печінки немає. Вільної рідини в черевній порожнині не виявлено
3.4	Аускультация з верифікацією виявлених патологічних змін	Я проводжу аускультацию з верифікацією виявлених патологічних змін Аускультативно — везикулярне дихання в легенях. Перистальтика ослаблена, що може бути ознакою інтоксикації або жовчної коліки.
4.Діагностика		

4.1	Проаналізувати клінічний аналіз крові	Я аналізую клінічний і біохімічний аналіз крові Я виявляю лейкоцитоз (10,3), зсув лейкоцитарної формули вліво (паличкоядерні — 10%), прискорене ШОЕ — 35 мм/год. Біохімічно: загальний білірубін 105,5 мкмоль/л (прямий 93,2 мкмоль/л) — ознаки механічної жовтяниці. Печінкові ферменти значно підвищені: АлАТ — 107,1; АСТ — 93,3 – цитоліз.
-----	---------------------------------------	--

		Гіперглікемія — 13,2 ммоль/л.
4.2	УЗД	Гіперехогенна тінь (конкремент) у холедоху з акустичною доріжкою – холедохолітіаз. Збільшений жовчний міхур.
4.3	Встановити попередній клінічний діагноз	Механічна жовтяниця на тлі холедохолітіазу. Гострий обтураційний холангіт. ЖКХ.
5. Визначення тактики ведення та лікування		
5.1	Медикаментозна терапія, фізіотерапія, особливості харчування	Я призначаю інфузійну терапію, антибактеріальні препарати широкого спектру (цефтриаксон 1г 2 р в д, метронідазол 500 мг 3 р в д), спазмолітики(дротаверин 2мл). Готую пацієнта до дообстеження: ЕРХПГ (ендоскопічна ретроградна холецисто панкреато графія.) — з метою підтвердження рівня обструкції та видалення конкременту(папілосфінкторотомія, літоекстракція). Харчування — повне голодування з наступним переходом на щадну дієту №5.
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6.1	Рекомендувати профілактичні заходи	Я рекомендую уникати вживання жирної їжі, алкоголю, дотримуватись дієти №5. При наявності ЖКХ необхідно регулярно спостерігатися у гастроентеролога, своєчасно вирішувати питання про оперативне лікування. Своєчасне реагування на будь-які ознаки жовтяниці — обов’язкове.
7.Інше		

7.1	Інформування пацієнта про можливі ризики хвороби	Я інформую пацієнта про можливі ризики хвороби .Я пояснюю, що механічна жовтяниця — це загрозливий стан, який може ускладнитися сепсисом, печінковою недостатністю, перитонітом. Пацієнту необхідно пройти дообстеження і, ймовірно, оперативне втручання. Спілкуюсь із повагою, детально відповідаю на всі запитання, дотримуюсь етичних норм.
-----	--	--

Чек-лист до практичної навички «Пальцьове дослідження прямої кишки»

1	Встановити контакт з пацієнтом (привітатись, представитися, позначити свою роль). Коректне розташування лікар-пацієнт (лежачи на боці з зігнутими в тазостегнових та колінних суглобах ногами, у колінно-ліктьовому положенні)	Сказати
2	Отримати інформаційну згоду на проведення діагностичних маніпуляцій	Сказати
3	Обробити руки антисептиком на гігієнічному рівні (лікар в рукавичках), вказівний палець рясно змастити змазкою	Виконати
4	Оглянути області заднього проходу	Виконати/ Сказати
5	Коректне пальцьове дослідження прямої кишки (обережно ввести вказівний палець в задній прохід, послідовно обмацати стінки анального каналу, послідовно обстежити стінку кишки по всій поверхні та на всьому доступному протязі, провести палець у ампулу прямо кишки)	Виконати
6	Оцінити: - стан просвіту ампули прямої кишки (зіяння, звуження)	Сказати
7	Оцінити: - характер відокремлюваного (слизове, кров'янисте, гнійне) - колір калових мас	Сказати
8	Визначити відхилення від норми (так, ні)	Сказати
9	Уточнити у пацієнта його самопочуття	Сказати